四、病毒性心肌炎

1.临床表现

①**1-3 周感染病史**

必看主诉：1-3 周前驱感染病史（发热、咽痛等上呼吸道感染、消化道症状、皮肤感染等）：病毒性心肌炎、急性非特异性心包炎、亚甲炎、肾小球肾炎（名字里带“炎”的，考的最多的是急性和急进性）、IgA 肾病（1-3 天）（心肌炎心包炎亚甲肾炎 3 周现、IgA 肾病 3 天现）

心肌细胞受损

②随后可心悸（与体温不相称一般体温每升高 1 度心率每分钟可增加 12-18 次），心律失常，胸痛

③**左心功能不全为主的表现**：呼吸困难、肺部湿啰音、S_1 低、奔马律、心尖部收缩期杂音 左心扩大→相对性二闭

④严重者可休克、**钟摆律**（**酷似心梗**）第一心音和第二心音都很弱→分不出来,听到单音律（主要见于非常严重病毒性心肌炎、严重心肌梗死）

可能可能最可能：1-3 周感染病史，随后可胸痛、左心功能不全，心悸与体温不相称

必看主诉

2.检查

病毒性心肌炎和心肌梗死很像
相似点:都有胸痛、左心功能不全表现、休克、钟摆律
鉴别:病毒性心肌炎有1-3周前驱感染病史;心肌梗死没有

①金标准：心肌活检（柯萨奇 B 组病毒等）

②病理 Q 波，**心肌坏死标志物如肌钙蛋白 cTn、肌酸激酶同工酶 CK-MB↑**

肥心病:q波(室间隔厚了,QRS是心室除极,q波可以看成室间隔除极,深而不宽)
心肌梗死:Q波(又宽又深)

注意：病理 Q 波可见于急性 ST 段抬高型心梗、急性心肌炎、肥心病、扩心病等

ST段压低、T波倒置、病理Q波:肥心病、扩心病、限心病、病毒性心肌炎(不要看到病理Q就选心梗)

真题解析 • 心肌疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2016N93-95 A 男性，70 岁，三个月前出现活动后胸闷、头晕，曾晕厥一次，近一周来上一层楼即感心前区疼痛，2 小时前因再次感胸痛伴短暂晕厥来院，既往糖尿病史 12 年，吸烟 35 年。查体：P 82 次/分，BP 100/85mmHg，神志清，颈静脉无怒张，双肺(-)，心尖搏动抬举样，心界向左下扩大，心律整，S_1 低钝，胸骨右缘第二肋间可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，粗糙，喷射状，向颈部放散，$A_2<P_2$，下肢不肿。

主动脉瓣狭窄

93.该患者最可能的诊断是

血流往主动脉方向 A2↓(看压力)或P2↑
主动脉压力↓=主动脉血液↓

A.主动脉瓣狭窄

B.肥厚型梗阻性心肌病 胸骨左缘三四肋间

有杂音必看杂音,先从杂音入手(一看部位,二看时期,三看器质/功能)
主狭危险因素类似冠心病

C.不稳定性心绞痛

D.病态窦房结综合征

94.为明确诊断，以下哪项无创性检查意义最大

A.常规体表心电图

B.24 小时动态心电图

C.冠状动脉 CT

D.超声心动图

95.为缓解胸痛、晕厥，应选用的最佳治疗是

A.静注硝酸酯制剂

B.应用大剂量 β 受体阻滞剂

C.心脏瓣膜置换术

D.介入治疗